جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : امينه انور محمد مصطفى
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 27710282101865 **رقم التليفون :** 01146642836 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 28-10-1977 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: امينه انور محمد مصطفى
National ID: 27710282101865

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

امينه
انور محمد مصطفى عبادى
٧٢ش سيدقره-الطالبيه
العمرانية - الجيزه

٢ ٧٧ ١٠ ٢٨ ٢١ ٠١٨ ٦٥

LJ1366644

National ID - Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

Name: امينه انوار محمد مصطفي	
MR. : 3379	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient presented requesting continuation of FEMARA therapy; supportive treatment was planned for a duration of three months following breast surgery performed on 29-11-2025, and the medication was provided free of charge.

The patient was evaluated with an upfront left breast cancer, pathologic stage T4 N0 M0. The treatment plan included four cycles of adjuvant chemotherapy (TC), placement of a PORT, and adjuvant endocrine therapy with an aromatase inhibitor (FEMARA). Zoladex was to be obtained from the pharmacy upon approval.

The patient has a history of left breast cancer diagnosed on 07-11-2024, pathologic stage T4 N0 (4 positive nodes), IDC grade 3, estrogen receptor 8/8, progesterone receptor 8/8, HER2-negative. The recommended regimen is four cycles of TC followed by tamoxifen. The treatment plan was modified to increase the end thickness and shift to FEMARA and Zoladex starting from September 2025. Imaging in November 2025 demonstrated a BIRADS 2 left well-defined seroma; a new ultrasound was ordered to assess the response to Zometa, FEMARA, and Zoladex.

The patient is currently prescribed FEMARA, ZOLADEX, and supportive care for three months. The medication was dispensed for delivery, and the next follow-up visit is scheduled for 28-10-2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : Reham Ahmed Fathy Ibrahim

يعتمد ,

Patient Name	:الأستاذه / امينه انور محمد مصطفي	Request No.	: 13004959
Patient No.	:27710282101865	Request Date	: 07/11/2024
Path No.	:4302/24	Verification Date	: 18/11/2024
Sex	:Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	:46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast mass.

Nature of the specimen:
Left wide local excision and sentenil lymph node biopsy specimens , collected at 7/11/2024.

Gross Examination:
Two specimens were recieved :
-Sentenil lymph node biopsy:Fibrofatty tissue piece measured 4x3.5 cm , enclosing 4 nodules up to 1.8x1 cm.
-Left wide local excision specimen measured 10x7.5x5 cm with covering skin ellipse measured 4.5x1.5 cm.
- Tumor extent
o Number: An ill defined firm greyish white mass.
o Size: 2.5x2.3x2 cm.
o Skin involvement: Free grossly.
- Distance from margins: 2 cm from both inferior and superior margins, 4 cm from medial margin, 3.5 cm lateral margins, 1 cm from superficial margin and 1.5 cm from deep margin.
- Frozen section:
-Free SLNs(0/4).
-Free margins.

Microscopic examination:
- Histological type:Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1).
- Angioinvasion: Not detected.
- Ductal carcinoma in situ: Minimal.
- Lymph node involvement:Free SLNs (0/4) .

Verified by :
dr.esraa magdy

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Ameena Anwar Mohamed Moustafa Abadi	Date : 16/09/2024
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 3012/2024	Pat. ID: 77255

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. **Chest:**
   - Left breast UIQ spiculated soft tissue nodule is seen measuring about 2.2x 2.3 cm.
   - Few small left axillary lymph nodes all show preserved fatty hila.
   - No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
   - No hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
2. **Abdomen and pelvis:**
   - The liver is enlarged in size with homogenous low attenuation CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic collections.
   - Tiny right humeral head sclerotic focus, mostly bone island.
   - No suspicious lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

- ***Left breast UIQ malignant mass.***
- ***No CT evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits.***

Dr. Ghada M. Khalifa, MSc

Dr. mohamed Mohsen, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name	: الأستاذه / امينه انور محمد مصطفي	Request No.	: 13001264
Patient No.	: 27710282101865	Request Date	: 13/08/2024
ath No.	: 2898/24	Verification Date	: 11/09/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

inical data
ft breast swelling.

ature of specimen
u cut biopsy, collected at 13/8/2024.

chnique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) d stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and matoxylin as counter stain. The sections treated against:
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

sults:
PT (Positive control showed appropriate reactivity):
ER: Strong nuclear reaction in 90% of the tumor cells (score 8/8).
PR: Strong nuclear reaction in 90% of the tumor cells (score 8/8).
Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
Ki67: 10% nuclear reaction of tumor cells.

nclusion:
ft breast swelling, Tru-cut biopsy:
vasive duct carcinoma, Grade II.
T:
ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 8/8).
Her2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 10% of tumor cells.

Verified by :

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / امينه انور محمد مصطفي	Request No.	13001264
Patient No.	27710282101865	Request Date	13/08/2024
Path No.	2898/24	Verification Date	11/09/2024
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - مباشره
Age	46 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	Mrs.Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Scoring system: "ER, PR"
SCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, 1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 7%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and , strong). Total score from 0 to 8.
Scoring system: "Her2"
eference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining bserved or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of ıe invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely erceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane :aining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or ɔmplete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor ells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor ells.

Signature
Prof.Dr. Gamal Abdelatty.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :

CAP
غرفة رقم (4) – الدور الاول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : امينة نور محمد مصطفى
Sex: Female
3- Medical number: 83229825
Old Med :
3012-2024
2-ID number:
Patient Age : 47 Y

Family history	Family History: -VE	Phone	Phone: 01146642838	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT: FIRST DISCUSSION
marital status	Marital Status: Married	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP: 2	Date of MDT	Date Of MDT: 03/12/2024
Co morbidity	Co Morbidity: DM	Menopausal status	Menopausal Status: Pre-Menopausal	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data

Breast Imaging :
R breast mass at 11 oclok 40 mm from nipple 25 x20 mm
non specific lymphadenopathy

Mets Workup :
cap:free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC BX COMMENT :	8/8 ER COMMENT :	8/8 PR COMMENT :	0 Her 2 Neu COMMENT :	SISH COMMENT :	10

T	N	M
2	0	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY
L.T WLE+SLNB: T2 ,LN 0/4

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN
FOR TC X 4 (DOCETAXEL CYCLOPHOSPHAMIDE)
PORT
TAMOXIFEN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY: د. امينة مصطفى / د. شريف حسنى	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]